

侵袭性纤维瘤 20 例临床分析

刘天润, 杨安奎, 陈福进, 魏茂文, 陈伟超

(中山大学肿瘤防治中心, 广东 广州 510060)

摘要: [目的] 探讨侵袭性纤维瘤的临床特点及外科治疗原则。[方法] 回顾分析 1987 年 1 月~2003 年 12 月间收治的 20 例侵袭性纤维瘤患者的临床病理资料。行局部广泛切除术者 13 例, 姑息性手术 6 例, 1 例放弃治疗, 术后行辅助放疗 2 例, 1 例放弃治疗。[结果] 全组病例 5 年复发率 30.0%, 手术切缘阳性者 5 年复发率 83.3%, 手术切缘阴性者 5 年复发率 7.7%。全组无术后死亡病例。[结论] 侵袭性纤维瘤具有侵袭性生长及复发率高等特点; 局部广泛切除肿瘤, 保证切缘阴性为该肿瘤外科手术原则。

主题词: 纤维瘤病, 侵袭型; 外科手术; 肿瘤复发, 局部

中图分类号: R738.6

文献标识码: A

文章编号: 1671-170X(2005)06-0454-02

A Clinical Study on 20 Cases with Aggressive Fibromatosis

LIU Tian-run, YANG An-kui, CHEN Fu-jin, et al.

(Cancer Center of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510060, China)

Abstract: [Purpose] To investigate the clinical feature of aggressive fibromatosis and the principle of surgical resection. [Methods] Clinicopathologic data of 20 cases with aggressive fibromatosis from Jan. 1987 to Dec. 2003 were analysed. Of the 20 patients, 13 cases underwent wide local excision; 6 cases, palliative surgery and 1 case, gave up treatment. There are 2 cases radiotherapy in addition to surgery [Results] The overall local recurrence rate was 30.0%, while the recurrence rate in the cases with positive margine was 83.3% and the recurrence rate in the cases with negative margine was 7.7%. No death was found following operation. [Conclusion] Aggressive fibromatosis has characteristic of aggressive growth and high recurrence rate. Wide local resection with negative margins may be the principle of surgical resection of this tumor.

Subject words: fibromatosis, aggressive; surgical procedures, operative; neoplasms recurrence, local

侵袭性纤维瘤 (aggressive fibromatosis) 又称韧带样纤维瘤 (desmoid tumor), 是一种来源于纤维组织的罕见肿瘤, 其发病率占软组织肿瘤的 0.03%, 占纤维组织肿瘤的 1.19%^[1-4]。该病在病理上为良性表现, 临床上却具有侵袭性生长和极易复发的特性, 但不发生转移。目前, 手术为该病的主要治疗手段, 放疗和激素治疗也有一定的作用, 但效果均不理想。本文对我院 1987 年 1 月~2003 年 12 月收治的 20 例韧带样纤维瘤患者的临床特点、诊断及治疗情况总结如下。

1 材料与方法

1.1 临床资料

全组 20 例患者年龄 14~55 岁, 中位年龄为 28 岁, 男性 7 例 (35%), 女性 13 例 (65%)。19 例 (95%) 为单发, 1 例 (5%) 为全身多发。肿瘤长径 1.5cm~

15.0cm, 平均 8.5cm。肿瘤的原发部位: 头颈部 3 例 (15%)、四肢 3 例 (15%)、肩部 4 例 (20%)、胸背 3 例 (15%)、腹壁 3 例 (15%)、髂腰 3 例 (15%)、臀部 1 例 (5%), 其中原发于腹壁与腹壁以外其他部位者的比例为 3:17。侵犯邻近骨、神经或其他器官 7 例 (35%)。就诊原因主要为发现质硬、固定性肿物, 除有 1 例因肿物浸润其它器官时伴有疼痛外, 其他患者均无症状。病史为 2 周~3 年, 平均 8.4 个月。本组患者中, 16 例 (80%) 在我院首诊, 4 例 (20%) 为外院复发病例转入我院, 所有病例均经病理证实为侵袭性纤维瘤。

1.2 治疗方法

全组病例中, 19 例 (95%) 行手术治疗, 其中行局部广泛切除术 (肉眼手术切缘距肿瘤边缘外 2~3cm) 者 13 例 (65%), 姑息性手术 6 例 (30%), 姑息术后行辅助放疗 2 例 (10%), 剂量 50Gy~60Gy, 1 例 (5%) 于诊断后放弃治疗。

1.3 随访

随访信息来源于电话随访及门诊复查资料, 本

通讯作者: 杨安奎

收稿日期: 2004-12-27; 修回日期: 2005-08-08

组患者随访时间自确诊之日开始,随访截止 2004 年 5 月。

1.4 统计学分析

应用 SPSS10.0 进行统计分析,采用 Fisher's exact 检验,Kaplan-Meier 及 Log-rank 方法对无瘤生存状况和复发率进行分析。

2 结果

随访至 2004 年 5 月,失访 1 例(1993 年 9 月末次随访),其余全部生存。共有 6 例(30%)复发,平均复发时间 21.5 个月,因治疗后复发行 2 次或 2 次以上手术者 3 例(15%),未控 1 例(5%)。其中手术切缘阴性的病例术后复发 1 例(7.7%),仅行姑息手术切缘阳性者全部复发(100%),姑息手术后行辅助放疗者 1 例复发,放弃治疗者见肿瘤缓慢增长。切缘阴性组与阳性组的 2 年复发率分别为 7.7% 和 66.7%,有显著性差异 ($P=0.017$),2 年无瘤生存率分别为 92.3% 和 33.3%;5 年复发率分别为 7.7% 和 83.3%,也有显著性差异 ($P=0.003$),5 年无瘤生存率分别为 92.3% 和 16.7%,可见手术切缘阳性的复发率高于手术切缘阴性者(见表 1)。

表 1 手术切缘阴性组与阳性组复发情况

手术切缘	总例数	复发例数		复发率		无瘤生存率	
		2年内	5年内	2年	5年	2年	5年
阴性	13	1	1	7.7%	7.7%	92.3%	92.3%
阳性	6	4	5	66.7%	83.3%	33.3%	16.7%

3 讨论

3.1 临床特征

该病多发生于女性,20~40 岁高发,Rodriguez-Bigas 等^[1]认为该病的发生可能与体内雌激素调控紊乱、创伤或遗传等因素有关。本组病例中女性占 65%,其中 11 例处于 20~35 岁之间,3 例有腹部手术史。

侵袭性纤维瘤在组织学上表现为纤维组织的良性增生,但生物学行为介于良性纤维瘤病变和纤维肉瘤之间,即具有浸润性生长和易复发的特性,但不发生转移。侵袭性纤维瘤常常浸润邻近的骨、神经、血管及重要的脏器,使手术难度增加,即使行局部广泛切除术后,复发率仍高达 40%~60%^[3]。本组病例中,7 例分别侵犯邻近的骨骼、肌肉或神经等,该组病例复发率为 30%,3 例出现二次复发。可见侵袭

性纤维瘤的浸润性较强并且复发率较高。

3.2 诊断

在临床上发现缓慢生长的质硬、固定、无痛、扁平宽大的肿物,尤其是 20~40 岁的女性的下腹壁出现类似肿物时,应考虑侵袭性纤维瘤的可能;影像学检查有助于确定该肿瘤的范围。侵袭性纤维瘤在临床上常常被误诊为纤维肉瘤,后者生长速度快,质地较软,常常有假包膜或坏死灶,细胞核异型性明显,核分裂相多见。该病的诊断主要依靠病理,由于冰冻手段的局限性,有时该病的术中冰冻结果报告为纤维瘤,此时应该结合临床特点进行判断。

3.3 治疗方案的选择原则

侵袭性纤维瘤具有浸润性生长和易复发的特点,所以治疗方法亦与恶性肿瘤相似。目前,治疗方案首选手术,手术原则即最大限度切除肿瘤,同时最大限度地保护肿瘤周围重要器官的功能。本组病例中切缘阴性组与阳性组的 2 年复发率分别为 7.7% 和 66.7%,差异显著 ($P<0.05$);5 年复发率分别为 7.7% 和 83.3%,也有显著性差异 ($P<0.05$),即手术切缘阳性者的复发率明显高于手术切缘阴性者,Kabiri 等^[3]的研究也表明同样的观点。因此,我们认为术中能否把肿瘤切除干净,保持切缘阴性,对于控制肿瘤具有重要意义,在权衡利弊后行肿瘤扩大切除术,胜

过手术配合辅助放疗方案。本组中有 3 例分别侵犯第 11 及 12 肋骨、膈肌和坐骨神经者,术中将肿瘤及其累及部分其它器官完整切除,随访期间,患者生存质量良好,未见肿瘤复发。因此,在保护邻近重要脏器的情况下,扩大切除肿瘤以保证切缘呈病理学阴性可作为治疗该肿瘤的外科原则。

参考文献:

- [1] Rodriguez-Bigas MA, Mahoney MC, Karakousis CP, et al. Desmoid tumors in patients with familial adenomatous polyposis[J]. Cancer, 1994, 74(4):1270-1274.
- [2] Tonelli F, Valanzano R, Brandi ML. Pharmacologic treatment of desmoid tumors in familial adenomatous polyposis: results of an in vitro study[J]. Surgery, 1994, 115(4): 473-479.
- [3] Kabiri EH, Al Aziz S, El Maslout A, et al. Desmoid tumors of the chest wall[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2001, 19(5):580-583.
- [4] Porru D, Stancati S, Giliberto GL, et al. Bilateral ureteral compression by multiple abdominal desmoid tumors in Gardner syndrome: case report and literature review [J]. Urology, 2004, 64(5):1031.